



## APRESENTAÇÃO

# Quem conduz esta conversa

## 1º Tenente Geraldo

Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco

### FORMAÇÃO ACADÊMICA



Engenharia Química — UFPE • Pós-graduação em APH

### ATUAÇÃO OPERACIONAL



CBMPE: operações de APH; resgate veicular; piloto de embarcações públicas; incêndio florestal

**Especialista em ocorrências com produtos perigosos — CBMBA**

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

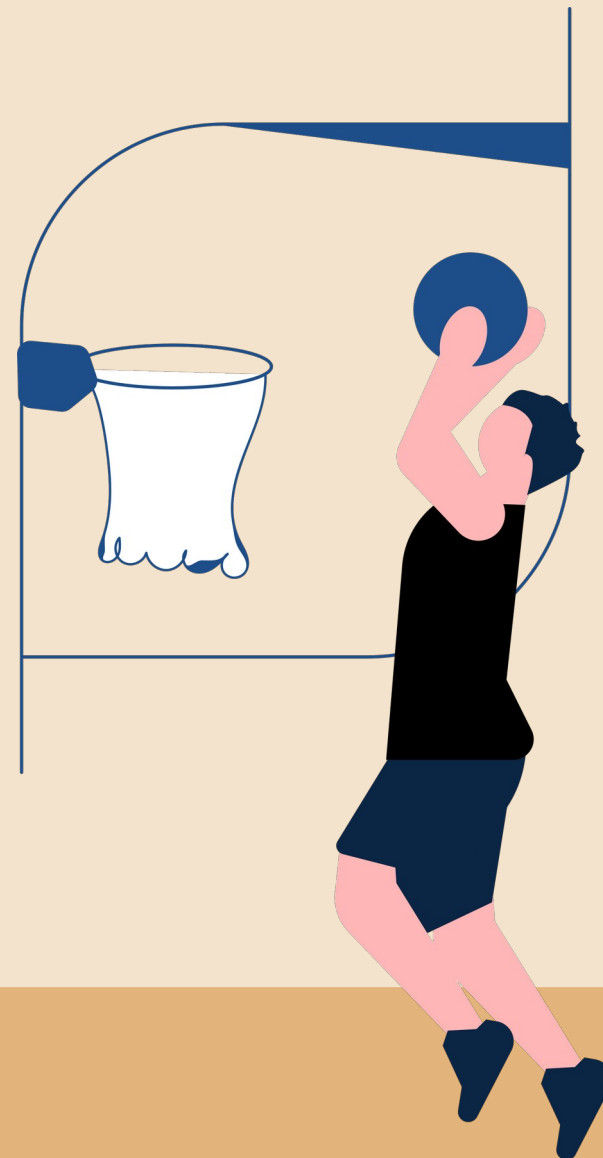
# Uma queda na quadra

- Um homem de cerca de 50 anos cai na quadra, sem bater a cabeça em nada.
- Chamam o nome e tocam os ombros: ele não responde.
- Ele não respira normalmente — faz um ruído parecido com um suspiro.



**O que fazer nos próximos 30 segundos?**

Fonte: Critério de reconhecimento: AHA 2025 — Part 7, §5.1 (inconsciente + respiração ausente ou anormal = parada cardíaca; COR 1 / C-LD). História: simulação editorial.



# Resposta — Uma queda na quadra



## Conduta correta

- 1 Não responde e não respira normalmente: presume-se parada cardíaca.
- 2 O ruído de suspiro (gasping) não é respiração.
- 3 Assumir a parada — não esperar para ter certeza.



## Erros comuns

- ✗ Esperar para ter certeza antes de agir.
- ✗ Tratar o suspiro como se fosse respiração normal.



**Em seguida: acionar a emergência e comprimir — é o que os próximos slides mostram.**

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

# O critério que muda a decisão



## Trate como parada cardíaca



Não responde ao chamado e não respira normalmente: trate como parada cardíaca.



Suspiro, ruído ou respiração ruidosa e irregular não contam como respiração normal.



Não se espera confirmação para começar.



## Não é RCP



Se responde e respira normalmente, não é RCP: é observar e chamar ajuda.



*Ilustração vetorial original • não demonstra técnica*

# Cadeia de sobrevivência



**1**

## **Reconhecer**

não responde e não  
respira  
normalmente.



**2**

## **Acionar**

192 (SAMU) ou 193  
(Corpo de  
Bombeiros).



**3**

## **Comprimir**

100 a 120 por  
minuto, sem pausa  
longa.



**4**

## **Desfibrilar**

DEA ligado o quanto  
antes.

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor • esquema não demonstra técnica*

## ACIONAR

# Sozinho: acionar primeiro, comprimir em seguida



Sozinho: acione a emergência e comece as compressões logo depois.



Na ligação, diga três coisas: local exato, o que aconteceu e o que já foi feito.



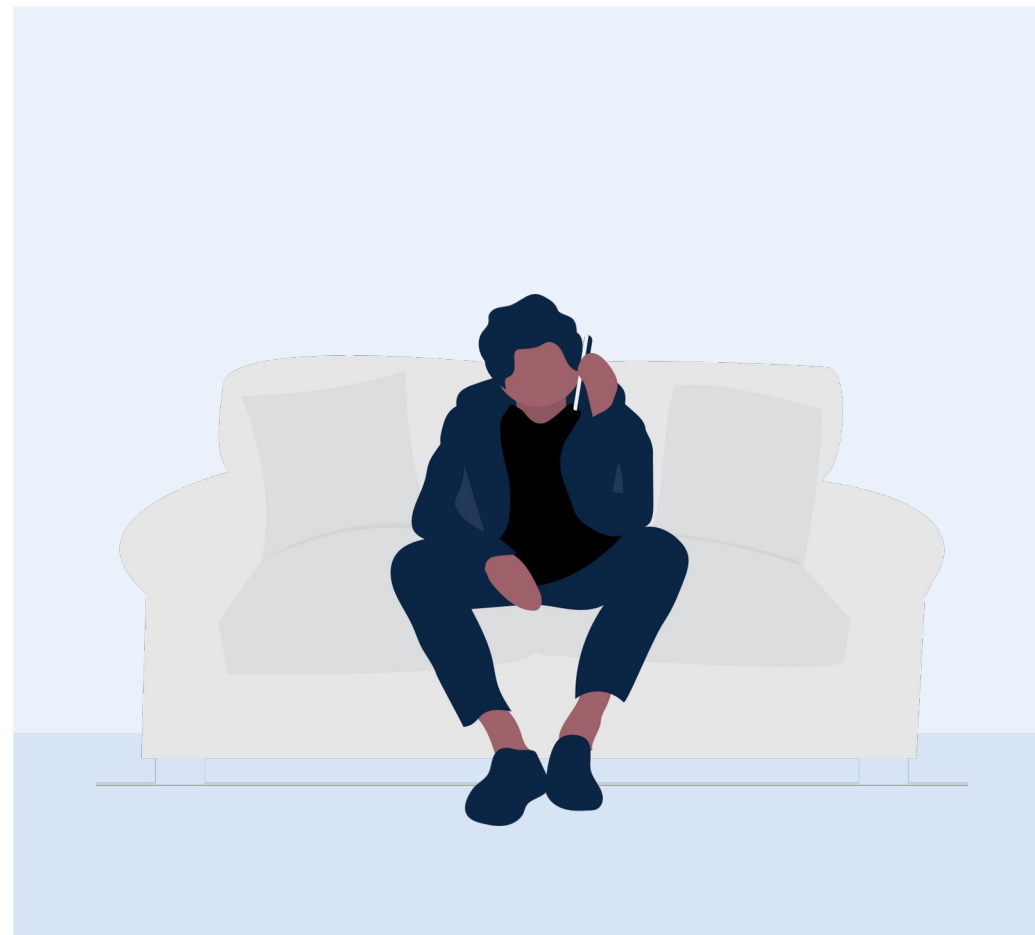
Fique no telefone e siga as orientações do atendente.



Com mais gente: um liga e busca o DEA enquanto o outro já comprime.



**Superfície firme; colchão faz o tórax afundar junto com o corpo.**



*Ilustração: unDraw (licença livre), cores adaptadas • cena de apoio*

# O que deve ser feito primeiro em caso de emergência?

## Opção 1

RESPOSTA CORRETA

Reconhecer



Chamar ajuda



Intervir

## Opção 2

NÃO É A REGRA GERAL

Reconhecer



Intervir



Chamar ajuda

## NA PRÁTICA



Com celular: ligue no viva-voz e comece enquanto fala com o atendente.



Com mais gente: um liga e busca o DEA; o outro já comprime.



**Exceção: sozinho e sem telefone — veja o próximo slide.**



Ilustração: unDraw (licença livre) • pictogramas: Health Icons e Phosphor

# A exceção: socorrista sozinho e sem telefone



Sozinho, sem telefone.  
A vítima não responde  
e não respira  
normalmente.



## ADULTO — OU CRIANÇA COM COLAPSO SÚBITO PRESENCIADO

**Primeiro acionar 192/193 e trazer o DEA; depois iniciar a RCP.**

*AHA 2025 — Part 7 (COR 1 / B-NR) • algoritmo pediátrico AHA/AAP 2025*



## CRIANÇA — COLAPSO NÃO PRESENCIADO

**Primeiro cerca de 2 minutos de RCP; se continuar sozinho, sair para acionar e buscar o DEA.**

*AHA/AAP 2025 — Pediatric BLS Algorithm, 1 socorrista*

**DIVERGÊNCIA: ERC 2025 = 1 MINUTO**



## AFOGADO

**Primeiro RCP com ventilações; o DEA vem depois e não pode atrasar a RCP.**

*AHA 2025 — Part 10, §11 Drowning (COR 1 / B-NR)*

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres) • esquema original*

# Por que a ordem muda?



## Adulto

### CAUSA

Parada geralmente súbita, de origem cardíaca, com o sangue ainda oxigenado.

### POR ISSO

**O choque precoce do DEA é o que mais ajuda: acionar e trazer o DEA vem primeiro.**



## Criança

### CAUSA

A parada costuma vir de falha respiratória ou choque, não do coração. Ritmos chocáveis são raros.

### POR ISSO

**Oxigênio e circulação já: cerca de 2 min de RCP antes de sair.**



## Afogado

### CAUSA

A submersão tira o oxigênio: para primeiro a respiração, depois o coração. Ritmo chocável em 2%–12%.

### POR ISSO

**A prioridade é ventilar: RCP com ventilações antes do DEA.**



## Sozinho

### CAUSA

Uma pessoa não faz duas coisas ao mesmo tempo: sair para ligar é ficar minutos sem RCP.

### POR ISSO

**Decide-se pela causa provável. Com celular, não há dilema: viva-voz e comprimir.**

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

# Os quatro números da compressão



## 100–120 /min

Frequência: 100 a 120 compressões por minuto.



## 5 a 6 cm

Profundidade: pelo menos 5 cm no adulto médio, sem passar de 6 cm.



## Recuo total

Recuo: deixar o tórax voltar por completo entre as compressões.



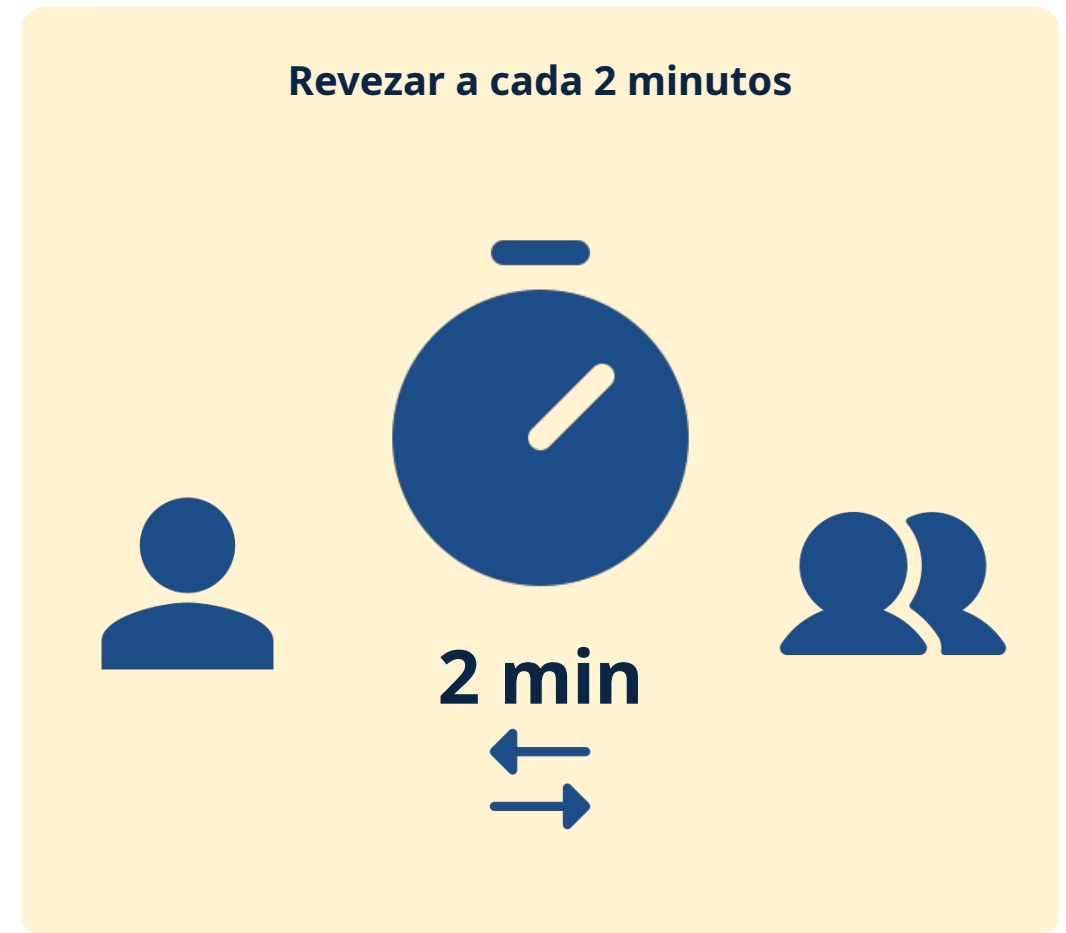
## Pausas mínimas

Pausas: as mais curtas possíveis, na menor fração de tempo possível.

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor • técnica só com manequim e instrutor*

# Manter a qualidade até a ajuda chegar

-  Com 2 ou mais pessoas: revezar quem comprime a cada 2 minutos.
-  A profundidade das compressões cai depois de 90 a 120 segundos.
-  **Não apoiar o peso do corpo sobre o tórax entre as compressões.**
-  Não há indicação rotineira de dispositivo mecânico para o público em geral.



*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

# Ventilações: 30 compressões por 2 ventilações



Com treinamento e sem via aérea avançada:  
30 compressões e 2 ventilações.



Cada ventilação em cerca de 1 segundo.



Volume apenas suficiente para ver o tórax  
subir.



**Ventilar pouco e ventilar demais fazem  
mal do mesmo jeito.**

## Proporção do ciclo

30 : 2



compressões



ventilações

*Esquema original • pictogramas Health Icons • técnica: demonstração ao vivo*

# Quando ventilar não é possível ou não é indicado



## Compressões contínuas



Sem treinamento, sem vontade ou sem material: compressões contínuas.



Não interromper a compressão para tentar ventilar.



## Com pulso, sem respiração normal



Pessoa com pulso mas sem respiração normal: 1 ventilação a cada 6 segundos.



Nesse caso específico não se comprime — aqui se ventila.

*Ilustração vetorial original • não demonstra técnica*

# DEA: ligar, colar, afastar, chocar, voltar a comprimir



**1**

## Ligar

Ligar o aparelho: ele fala o que fazer.



**2**

## Colar as pás

Expor o tórax e colar as pás onde o próprio DEA mostra.



**3**

## Afastar

Afastar todos durante a análise e durante o choque.



**4**

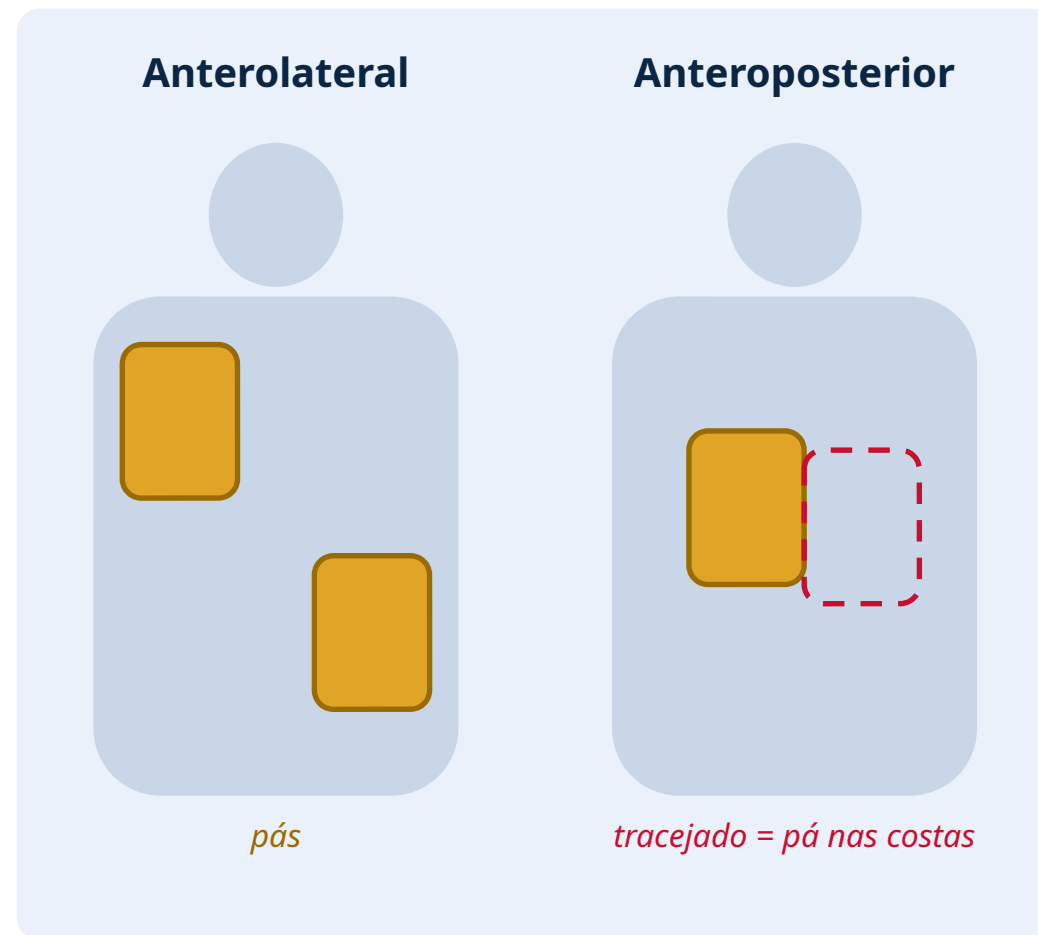
## Voltar a **comprimir**

Depois do choque, voltar a comprimir imediatamente.

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor • esquema não demonstra técnica*

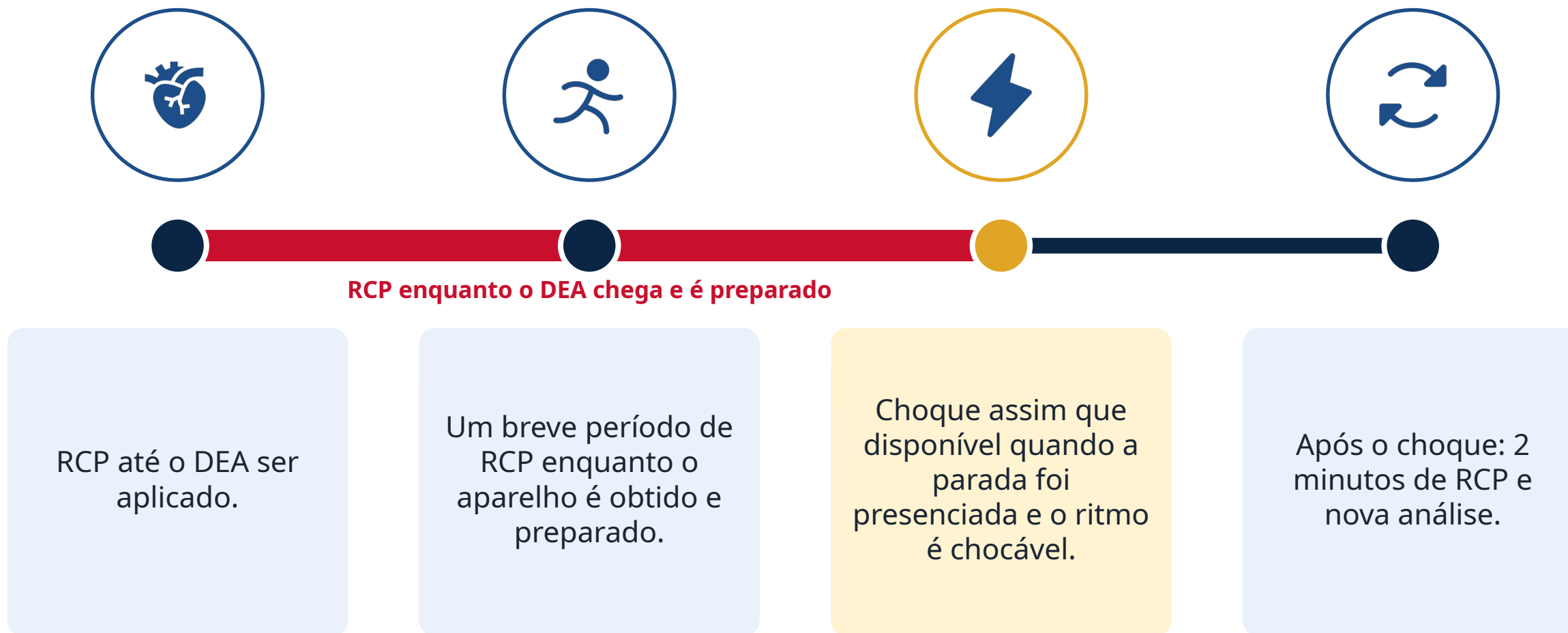
# Onde as pás vão

-  Posição anterolateral ou anteroposterior, conforme o aparelho mostra.
-  No adulto, eletrodo com diâmetro maior que 8 cm.
-  Tórax molhado ou muito sujo: secar antes de colar.
-  Ajustar o sutiã pode ser razoável; não é necessário retirá-lo.



Esquema vetorial original • siga sempre a figura do próprio aparelho

# RCP antes e depois do choque



*Ilustração vetorial original • não demonstra técnica*

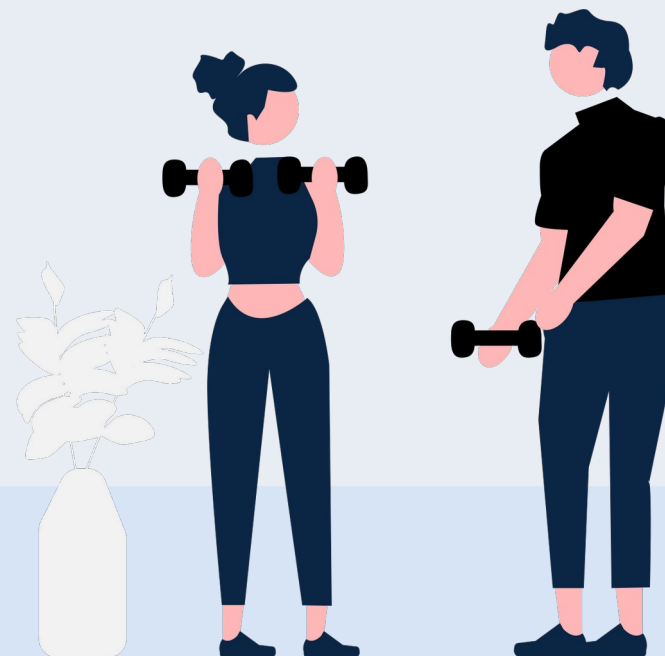
# A academia com o DEA na parede

- Numa academia, um homem de 55 anos desmaia durante o treino.
- Não responde e não respira normalmente.
- Há um DEA na parede, a 20 metros; o instrutor está sozinho com um aluno.



**Primeira decisão, em 30 segundos: o que vem antes de tudo?**

Fonte: AHA 2025 — Part 7, §5.1, §7.2, §7.3 e §9.1; AHA — Adult Cardiac Arrest Algorithm 2025. Caso simulado.



## Resposta — A academia com o DEA na parede



### Conduta correta

- 1 Assumir a parada cardíaca.
- 2 Acionar a emergência e iniciar compressões imediatamente.
- 3 Mandar alguém buscar o DEA.



### Erros comuns

-  Sair correndo para buscar o DEA antes de qualquer compressão: não se atrasa o início da RCP para obter o DEA.
-  Checar o pulso por um minuto: contraria o limite de 10 segundos e é conduta de profissional de saúde.



**O DEA não é pré-requisito para começar a comprimir.**

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

# A copa do escritório, duas pessoas

- Na copa do escritório, um colega de 60 anos cai da própria altura e fica imóvel.
- Duas pessoas estão presentes: uma tem treinamento, a outra não.
- Não há DEA no andar.



**O que cada uma faz, e em que ordem?**

Fonte: Critério e sequência: AHA 2025 — Part 7, §5.1, §7.2 e §8.2. História: simulação editorial.



## Resposta — A copa do escritório, duas pessoas



### Quem tem treinamento

- ✓ Conduz as compressões.
- ✓ Pede que alguém busque o DEA mais próximo.



### Quem não tem treinamento

- ✓ Liga para 192/193: local, o que aconteceu e o que já foi feito.
- ✓ Organiza o acesso do serviço ao andar.



**Quem não ventila não é obstáculo: compressões contínuas até a ajuda assumir. E não se manda buscar o DEA quem já está comprimindo.**

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

# Sozinha em casa, com o telefone na mesa

- Em casa, um morador de 70 anos desmaia na sala enquanto a filha está no local.
- Ele não responde ao chamado e não respira normalmente.
- Ela está sozinha e o telefone está na mesa.



**Qual é a primeira coisa a fazer?**

Fonte: Critério, ordem de acionamento e ventilação: AHA 2025 — Part 7, §5.1, §7.1 e §8.2; numeração de emergência do Brasil. História: simulação editorial.



## Resposta — Sozinha em casa, com o telefone na mesa



### Conduta correta

- 1 Chamar a emergência em viva-voz.
- 2 Começar as compressões imediatamente, seguindo as orientações do atendente enquanto comprime.



### Erros comuns

- ✗ Perder tempo procurando pulso: o público geral não faz checagem de pulso.
- ✗ Esperar para ver se melhora.



**Com treinamento: 30 compressões e 2 ventilações. Sem treinamento ou sem como ventilar: compressões contínuas.**

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

# Caso da turma: a decisão dos primeiros 30 segundos



**Caso: homem de 55 anos desmaia na academia; não responde e não respira normalmente.**

**A**

Buscar o DEA correndo, antes de qualquer compressão.

**B**

Checar o pulso por um minuto para ter certeza.

**C**

Assumir parada, acionar a emergência, comprimir e mandar alguém buscar o DEA.

**D**

Sentar a pessoa e oferecer água.

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

# Resposta — a decisão dos primeiros 30 segundos

## RESPOSTA CORRETA



**Assumir parada, acionar a emergência, comprimir e mandar alguém buscar o DEA.**



**Por que não**

Atrasa a compressão: a diretriz é explícita em não atrasar a RCP para obter o DEA.



**Por que não**

Contraria o limite de 10 segundos da checagem de pulso, e checar pulso é conduta de profissional de saúde.



**Por que não**

É inútil e atrasa o atendimento.



**Quando o DEA chegar: ligar, colar as pás, afastar todos, chocar se indicado e voltar a comprimir sem pausa para checar o ritmo.**

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

# Recapitulando: reconhecer, acionar, comprimir, desfibrilar



## Reconhecer:

inconsciente e sem respiração normal — suspiro não é respiração.



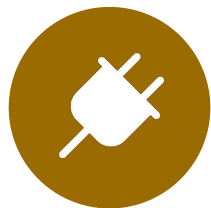
## Acionar:

192/193, com local, o que aconteceu e o que já foi feito.



## Comprimir:

100 a 120 por minuto, 5 a 6 cm, recuo completo, pausas mínimas.



## Desfibrilar:

DEA ligado o quanto antes e compressões retomadas logo após o choque.

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

## Questão 1 — Frequência das compressões



Qual é a frequência de compressões torácicas recomendada para o adulto em parada cardíaca?

**A**

60 a 80 compressões por minuto

**B**

120 a 140 compressões por minuto

**C**

100 a 120 compressões por minuto

**D**

O mais rápido que o socorrista conseguir

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

## Questão 2 — Profundidade da compressão



Qual é a profundidade de compressão recomendada no adulto médio?

**A**

Pelo menos 5 cm, evitando passar de 6 cm

**B**

Pelo menos 2 cm, sem limite máximo

**C**

Exatamente 8 cm em todos os adultos

**D**

A profundidade é definida apenas pelo retorno do tórax, sem valor de referência

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

## Questão 3 — Proporção entre compressões e ventilações



No adulto em parada cardíaca, sem via aérea avançada, qual é a proporção recomendada?

**A**

15 compressões para 2 ventilações, em qualquer situação

**B**

5 compressões para 1 ventilação

**C**

Somente compressões, mesmo com socorrista treinado

**D**

30 compressões para 2 ventilações

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

## Questão 4 — Logo depois do choque



O DEA aplicou o choque. O que se faz imediatamente depois?



Parar e checar o ritmo no monitor antes de qualquer coisa



Retomar as compressões imediatamente, sem pausa para checar o ritmo



Aplicar um segundo choque em seguida, sem compressões



Aguardar o aparelho mandar comprimir, sem tocar no tórax

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

## Questão 5 — Checagem de pulso para o profissional de saúde



**Profissional de saúde: quanto tempo pode durar a checagem de pulso nessa situação?**

**A**

Até 1 minuto, para não errar

**B**

No máximo 10 segundos; sem pulso percebido com certeza, começar as compressões

**C**

Não se checa pulso em nenhuma hipótese

**D**

Somente depois de 2 minutos de compressões

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

# Gabarito comentado

1 – **C** 100 a 120 compressões por minuto.

2 – **A** pelo menos 5 cm, sem passar de 6 cm.

3 – **D** 30 compressões para 2 ventilações.

4 – **B** retomar as compressões imediatamente após o choque.

5 – **B** no máximo 10 segundos de checagem de pulso, e só para profissional de saúde.



*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

## Referências — diretrizes de RCP e DEA



AHA — Part 7: Adult Basic Life Support (2025 Guidelines for CPR and ECC).



AHA — Adult Cardiac Arrest Algorithm, 2025 (PDF oficial).



AHA/AAP — Part 6: Pediatric Basic Life Support e Pediatric Cardiac Arrest Algorithm, 2025.



ILCOR — Basic Life Support: 2025 CoSTR (Resuscitation 2025).

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

## Referências — demais fontes e divergências declaradas



ERC 2025 — European Resuscitation Council Guidelines, Adult Basic Life Support.



AHA 2025 — Part 10, §4.6, circunstâncias especiais (afogamento).



**Onde as diretrizes divergirem, as versões aparecem lado a lado, com a origem nomeada.**

*Pictogramas: Health Icons e Phosphor (licenças livres)*

# Em quatro passos, do reconhecimento ao DEA



1

Não responde e não respira normalmente? Trate como parada cardíaca.



2

Acione 192/193 e diga local, o que aconteceu e o que já foi feito.



3

Comprima 100 a 120 por minuto, 5 a 6 cm, com recuo completo.



4

**Aplique o DEA assim que ele chegar e volte a comprimir logo após o choque.**

*Ilustração vetorial original • não demonstra técnica*

